

SOAL UJIAN OSCE STATION
ANESTESIA OBSTETRIK

1.	No. Station	7B
2.	Judul Station	Painless Labour – Anestesi Epidural
3.	Waktu Yang Dibutuhkan	17 menit
4.	Tujuan Station	Menilai Kemampuan Evaluasi Pra Anestesia, Diagnosis dan Problem Aktual – Potensial, Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme.
5.	Kompetensi	Evaluasi Pra Anestesia Diagnosis dan Problem Aktual – Potensial - Rencana Tindakan Anestesi Keterampilan Klinis Monitoring dan Manajemen Penyulit - Manajemen Pasca Anestesia Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme
6.	Kategori	Anestesia Obstetrik - Anestesia Bedah Saraf - Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri - Anestesia Bedah Toraks - Anestesia Pediatrik - Anestesia Kegawatdaruratan - Anestesia Urologi - Anestesia Untuk Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) - Anestesia Bedah Kepala Leher - Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah - Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal - Terapi Intensif
7.	Instruksi Untuk Peserta	<u>Skenario Klinik:</u> Seorang perempuan usia 20 tahun direncanakan partus spontan pervaginam dengan Epidural Labour Anesthesia. Pasien dengan keluhan mules – mules ingin melahirkan, riwayat keluar lendir bercampur darah dari kemaluan (+) hal ini dialami sejak 6 jam sebelum masuk rumah sakit. Ini merupakan hamil pertama. Mual (+), riw. Hipertensi selama hamil (-). <u>Instruksi Untuk Peserta:</u> - Lakukan evaluasi pra anestesia pada pasien ini! - Sebutkan problem aktual – potensial yang mungkin terjadi pada pasien ini! - Lakukan anestesi epidural pada pasien ini! - Pada bukaan serviks lengkap, pasien mengeluhkan nyeri. Jelaskan tindakan saudara!
8.	Instruksi Untuk Penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> - Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian. - Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! - Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian. - Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji!

		5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! <u>INSTRUKSI KHUSUS</u> 1. Penguji memberikan lembar anamnesis pasien yang telah disediakan dan mengamati dan menilai tindakan pra anestesia yang dilakukan peserta dan memberikan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (hanya bila diminta oleh peserta!). Anamnesis : Allergy: asam mefenamat Medication : - Past illness : Dispepsia Last Meal : 10 jam sebelum operasi, Event : Mules – mules ingin melahirkan, Nyeri saat kontraksi Tanda Vital: Tekanan darah 130/90mmHg, laju nadi 114x/menit, laju napas 22 x/menit, Temp 36.5°C NRS Diam 3-4/100 mm dan NRS bergerak 3-4/100 mm. BB 98kg, TB 160cm. DJJ140 x/menit Sistem pernapasan: Airway LEMON SCORE BAIK (Look externally, Evaluate, Mallampati, Obstruction, Neck mobility) Paru-paru: dalam batas normal Pemeriksaan fisik lain: dalam batas normal Status obstetrik: bukaan serviks 3 cm Laboratorium Darah Rutin: Hb 9gr%, Hct 36.5, WBC 14.500gr%, Plt 155.000 gr%. Faal hemostasis: PT, APTT, INR dalam batas normal 2. Penguji menilai peserta menyebutkan problem aktual-potensial: Problem aktual: 1. Hamil 2. Cemas 3. Nyeri 4. Obesitas Problem potensial : 5. Alergi obat 6. Mual muntah 7. Hipotensi 3. Penguji menilai peserta melakukan tindakan epidural. Anestesi Epidural: 1. Melakukan persiapan alat dan obat 2. Memeriksa kesiapan alat emergensi 3. Melakukan pemasangan monitor standar dan mengamati tanda vital.
--	--	--

		4. Memposisikan pasien lateral decubitus kiri atau duduk 5. Membuat landmark yaitu L3-L4 sejajar dengan aspektus superior krista iliaka (<i>Tuffier's line</i>) dan menentukan titik penusukan. 6. Cuci tangan dan memakai gaun bedah steril, memakai sarung tangan steril. 7. Melakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada landmark yang sudah ditentukan dan menutupnya dengan doek lobang steril. 8. Melakukan infiltrasi anestesi lokal pada celah yang akan dilakukan penusukan jarum Tuohy. 9. Melakukan penusukan jarum Tuohy, dan identifikasi ruang epidural dengan teknik LOR (<i>Loss of Resistance</i>) atau <i>Hanging Drop</i>. 10. Memastikan letak ujung jarum tidak pada ruang subarachnoid dan memperhatikan kedalaman jarum 11. Masukkan kateter epidural melalui jarum. 12. Memastikan panjang kateter epidural yang masuk ke ruang epidural 3 - 5 cm. 13. Menghubungkan kateter epidural dengan alat pengunci dan filter epidural 14. Memberikan <i>test dose</i> (kombinasi anestesi lokal dan epinefrin yaitu 3 ml lidokain 2% dan epinefrin 1:200.000 (5 mcg/ml). Memastikan <i>test dose</i> negatif. 15. Memasukkan obat anestesi lokal secara bertahap 16. Memastikan blok epidural berjalan baik, dengan teknik pinprick, suhu, maupun teknik lain 4. Penguji menilai peserta menyebutkan tindakan. a. Memposisikan pasien <i>head-up</i> / setengah duduk b. Memberikan tambahan volume anestesi lokal secara bertahap	
9	Tata letak ruangan	Model kamar operasi	
10	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran : 1 Tugas Laboran : Sebagai penata anestesi, membantu peserta dalam melakukan persiapan dan tindakan anestesi.	
11	Peralatan Yang Dibutuhkan	- Peralatan ruang operasi - Manekin spinal - Epidural set - Nampun alat - Duk lobang - Cawan 2 buah dengan label povidone iodine, alkohol, - Korentang	1 set 1 buah @ 3 buah 1 buah 1 buah 1 set 1 buah

		- Kassa - Topi dan Masker - Sarung tangan steril 6,5 7 7,5 - Alkohol 70% - Povidone iodine 10% - S spuit 5 cc, 10 cc - Plester - Gunting - Obat anestesi lokal (lidocaine, bupivacaine, ropivacaine) -	5 buah @1 kotak @10 buah 1 botol 1 botol @ 5 buah 2 set 1 buah 1 buah 1 buah -
12	Kebutuhan Manekin	Manikin epidural	
13	Penulis	TIM OSCE ATI	
14	Referensi	Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology 6 th ed. Lange. 2018	

RUBRIK ACTUAL MARK

STATION OBSTETRIK

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Evaluasi Pra Anestesia 1) Anamnesa langsung kepada pasien, AMPLE : lengkap 2) Pemeriksaan Fisik : Lengkap 3) Pemeriksaan Penunjang : Lengkap	Peserta tidak melakukan evaluasi dan persiapan praanestesi	Peserta melakukan 1 evaluasi secara tidak lengkap	Peserta melakukan 2 dari 3 evaluasi tidak lengkap ATAU 1 dari 3 evaluasi dilakukan secara lengkap	Peserta melakukan evaluasi secara lengkap.	2	
2. Diagnosa dan Problem Aktual – Potensial Problem aktual: 1. Hamil 2. Cemas 3. Nyeri 4. Obesitas Problem potensial : 5. Alergi obat 6. Mual muntah 7. Hipotensi	Kandidat tidak mampu mengidentifikasi problem	Kandidat mampu melakukan identifikasi 1-3 problem	Kandidat mampu melakukan identifikasi 4-5 problem	Kandidat mampu melakukan identifikasi 6-7 problem	2	
4. Keterampilan klinis Anestesi Epidural	Peserta ujian tidak melakukan tindakan epidural	Peserta ujian melakukan tahapan tindakan epidural	-	Peserta ujian melakukan tahapan tindakan epidural anestesi dengan	3	

	anestesi	anestesi namun tidak lengkap		benar, lengkap dan runut		
5. Monitoring dan manajemen penyulit 1. Memposisikan pasien <i>head-up</i> / setengah duduk 2. Memberikan tambahan volume anestesi lokal secara bertahap	Peserta tidak melakukan tindakan apa-apa	-	Peserta hanya melakukan salah satu tindakan	Peserta melakukan seluruh tindakan	2	
7.Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan point komunikasi edukasi dan profesionalism e.	Peserta meminta izin secara lisan dan 1-2 point komunikasi edukasi dan profesionalisme	Peserta meminta izin secara lisan dan 3-4 point komunikasi edukasi dan profesionalisme.	Peserta meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap	1	
TOTAL SKOR						

LEMBAR ANAMNESIS PASIEN STATION 1

Nama : WATI
Jenis Kelamin : Wanita
Usia : 20 tahun
BB : 98 kg TB : 160 cm
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga
Status Pernikahan : Menikah
Alamat : sesuai

Keluhan utama : Mules mules mau melahirkan

Riwayat Penyakit Sekarang

- Mulas – mulas mau melahirkan
- Nyeri diseluruh lapangan perut hilang timbul.
- Riwayat Penyakit dahulu : tidak jelas
- Riwayat Alergi :
 - ✓ Obat : asam mefenamat
 - ✓ Makanan : Tidak ada
 - ✓ Debu / dingin : Tidak ada

Riwayat Keluarga

- Riwayat keluarga darah tinggi dan kencing manis : Tidak ada
- Riwayat stroke di keluarga: tidak ada

Riwayat Pengobatan: Tidak ada

Riwayat Operasi : Tidak pernah.

Riwayat kebiasaan

- Merokok : Tidak pernah
- Berolah raga : Jarang
- Minum kopi / alkohol/ obat herbal: -/-/-
- Makan 2x sehari terdiri dari nasi, sayur, tahu dan tempe. Daging/telur jarang. Buah-buahan kadang-kadang dikonsumsi.
- Kadang-kadang juga konsumsi makanan kecil : pisang goreng, ketela goreng, kacang goreng atau panganan tradisional lain.

Riwayat Sosial : Ibu Rumah Tangga

Peran yang harus dilakukan pasien dalam keadaan duduk, tampak cemas, berdiskusi dengan dokter dan menanyakan masalah jenis tindakan anestesi yang aman untuk menghilangkan rasa nyeri pada saat partus spontan.

HAL YANG DISAMPAIKAN PASIEN: “Dok, saya tidak mau ada rasa sakit seperti ini saat melahirkan ini dan tidak mau ada rasa nyeri bekas jahitan setelah melahirkan